

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	腎性貧血 Anemia Related To Renal Failure				
編號	A31000-Q03-W-E06	制定者	HD 黃麗真	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/8 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解腎性貧血的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

大部分的紅血球生成素(EPO)是經由腎臟製造，腎臟病病人因為腎臟製造紅血球生成素的細胞受損，不能製造紅血球生成素，沒辦法足夠刺激骨髓造血，另一方面為鐵的缺乏，除此之外會導致貧血的相關因素為：慢性出血、鐵質吸收差、慢性炎症反應、紅血球生存時間短、缺乏葉酸、維他命及 B12 均有相關。

（二）症狀

眩暈(dizziness)、昏倒、全身疲憊、四肢軟弱無力、心悸、對冷的感受度增加、食慾下降、男性性慾下降、女性月經失調、皮膚蒼白、運動時呼吸困難等症狀。

（三）常見檢查

- 1.血色素(Hemoglobin；Hb)。
- 2.血比容(Homocytotrophic；Hct)。
- 3.血清鐵(Fe)。
- 4.總鐵結合能力(Total iron-binding capacity；TIBC)。
- 5.運鐵蛋白(Fe／TIBC)。
- 6.血清儲鐵蛋白(Ferritin)。

主題名稱	腎性貧血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E06	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/8

(四) 常見治療

1. 皮下或靜脈注射造血功能治療劑 Eprex(EPO)。

(1)每週每公斤體重給予 80-120 單位，分成二至三次給予。

A. 作用：是一種能刺激紅血球製造的純化醣蛋白。是由哺乳動物細胞經由人類紅血球生成素嵌進的基因組合製造而成。紅血球生成素是一種能調節紅血球製造的內生性醣蛋白荷爾蒙。

B. 副作用：血壓上升、注射部位栓塞，注射以後引起的感冒樣症狀（骨頭疼痛及發冷）、皮膚反應、眼瞼水腫。

2. 靜脈注射或口服補充鐵劑，使造血原料不致於匱乏，但是透析病人腸胃道對鐵劑吸收不佳，會建議以靜脈注射補充為優先，若對鐵劑靜脈注射有過敏反應，則可口服鐵劑補充。

(1) 適應症：依據 2012KDIGO 建議鐵蛋白(serum ferritin)≤500ng/dl 及運鐵蛋白飽和度(transferrin saturation,TSAT)≤30%，應額外補充鐵。且在末期腎病變目標值分別為：血紅素 10-11.5g/dl，鐵蛋白：200~1,200ng/dl，TSAT30~50%。

(2)鐵劑(Fe-Back)作用：本劑為三價鐵，但為高分子特殊複鹽，即所謂膠性鐵劑。本劑可多量地注射血液中，且一旦滲透入細網內皮系，則漸解離成 Transferrin，或 Ferritin 及 Hemosiderin，然後運行至骨髓，被利用來合成血紅素及貯藏鐵。

(3)副作用：偶有輕度之發熱、頭痛。

3. 按時服用磷結合劑，避免血磷升高引起副甲狀腺機能亢進，影響骨頭造血功能。

4. 輸血。

5. 足夠透析量。

6. 飲食營養攝取。

(五) 護理問題

1. 易受傷害／血比容小於 30%。

2. 易受傷害／跌倒。

3. 缺乏營養／食物攝取不足。

(六) 護理措施

1. 受傷害／血比容小於 30%

(1)協助毒素充分的清除：透析護理時血流量保持>250ml/min。

主題名稱	腎性貧血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E06	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/8

- (2)教導病人多攝取動物性蛋白，例如：肉、魚、蛋、奶類，少攝取會使尿素氮上升的植物蛋白—豆類、豆干、花生、開心果、瓜子等。
- (3)鼓勵病人多攝取造血元素的食物
- A. VitB12：如肝臟、瘦肉、牛奶及蛋。
- B. 葉酸：依醫囑於每次血液透析後予葉酸 1 顆口服並告知多攝取深色蔬菜的食物，如蕃茄、紅蘿蔔等食物。
- C. 鐵質：如紅肉、豬血、米血、蘋果、葡萄等；全穀類，乾果類，內臟類和海鮮類富含鐵質但也富含磷離子，食用時要小心血磷會飆高。並告知病人須多攝取蛋白質至少每公斤體重每天 1.2-1.5gm：大約一個手掌大及厚度的肉類或一顆蛋的量、豆腐一塊、牛奶一杯為一份，而病人須一天吃足三份，才可以有足夠的蛋白質攝取。
- (4)透析器及迴路管準備時，充分排氣，避免血液凝固。注意每次觀察透析過程中，人工腎臟及迴路管血液凝固的狀況並詳加記錄，漸進性增加抗凝劑使用量，至凝固情況改善為止，並注意病人出血情形。
- (5)每次透析前詢問病人是否有出血症狀：血尿、黑便、牙齦出血、皮下多處瘀血、穿刺針孔止血時間大於 15 分鐘等症狀。
- (6)持續評估病人貧血狀況：每兩週測量血比容一次，若使用 EPO 狀況下，維持每週血比容上升 1-1.5 範圍，注意無力、心悸、頭暈等狀況是否改善。
- (7)評估病人體內鐵(Ferritin)貯量狀況。若不足依醫囑給予鐵劑，在給予鐵劑時，密切注意是否有過敏症狀：皮疹、灼熱感、噁心、嘔吐、心悸等，並衛教多攝取含鐵食物。
- (8)注意病人 EPO 使用反應及狀況評估：每次透析前予量基本血壓並衛教至少每天在家量一次血壓且須維持在 150/90mmHg 以下。注意血比容變化需維持每週上升 1-1.5%，過慢須與醫師討論增加劑量，若上升大於 2 則須與醫師討論減少劑量。
- (9)依醫囑給予濃縮紅血球時的護理注意事項：
- A. 依一般輸血護理原則核血，並注意輸血過程反應。
- B. 輸血盡量在血液透析過程給予，並且須在透析收針前 30 分鐘完成輸血，以減少因輸血致血容積上升的水腫或血鉀上升。
- C. 輸血應由靜脈迴路管端給予，以免人工腎臟的凝固。

主題名稱	腎性貧血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E06	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/8

2. 易受傷害／跌倒

- (1) 衛教病人穿著合適衣服以免衣褲太大造成絆倒。
- (2) 當病人休息時將床擺置最低的位置。
- (3) 當病人有頭暈、血壓不穩，下床前要先坐於床緣，再由照顧者扶下床。
- (4) 若病人步態不穩，請使用穩固助行器或家人協助病人走路。
- (5) 提供室內足夠的燈光增加能見度。
- (6) 衛教病人應穿著具防滑的鞋子切勿打赤腳。
- (7) 隨時保持地面乾淨及走道通暢。
- (8) 教導病人需要協助而無照顧者在旁時請立即按鈴通知護理人員。

3. 缺乏營養／食物攝取不足

- (1) 瞭解病人飲食習慣及對食物之喜好，請病人記錄每天飲食內容，經分析與其討論再給予飲食衛教。
- (2) 計算病人每日所需攝取及實際食物攝取熱量。
- (3) 教導病人進食前口腔衛生的重要性，以加強對食物的味覺進而能攝取更足夠的營養。
- (4) 衛教病人改變烹調方式食物煮軟爛幫助咀嚼促進食慾。
- (5) 衛教病人每日可吃 1-3 個蛋白教導使用蒸、炒、煎煮方式的變化。
- (6) 建議病人少量多餐，以增加進食量。
- (7) 每月抽血檢查做營養評估，若 Albumin 小於 4.0mg/dl 給予飲食衛教，建議增加蛋白質攝取量。
- (8) 衛教病人營養狀況少於身體需要的症狀、徵象及避免的重要性。
- (9) 與營養師共同建立飲食計劃視病人情況及需求適時修訂。

(七) 衛教指導

低血壓

1. 衛教病人隨時觀察是否出現血壓下降之症狀如：頭暈、冒汗、腹痛、解大便之感覺軟弱、脈搏加快、減弱、胸悶等。
2. 衛教病人有血壓下降之症狀，採頭低腳高且頭側一邊之姿勢以增加血循。
3. 衛教病人勞累、睡眠不足，會使血壓更低，因而應保持規律生活充分休息，避免過勞、熬夜。
4. 衛教病人避免久站或突然改變姿勢，拾取地上東西時，不宜直接低頭，應先蹲

主題名稱	腎性貧血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E06	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/8

下；起床時，不要猛然站起身，應先確定身體已平衡，再慢慢起來。

- 5.衛教病人注意環境與穿著，不宜處在悶熱的環境，以免血管舒張、血壓下降。
- 6.衛教病人加強營養，具有低血壓傾向的人，若營養不足將使血壓更低；若加強營養則可使血壓接近正常值，伴隨的不適症狀也可減緩或消失。少吃會降低血壓的食物，不要常吃芹菜、冬瓜、綠豆、山楂、洋蔥等降壓利尿的食物。建議多吃豐富蛋白質、營養素多的肉類、雞蛋、牛奶、魚肉、豆類等食物。
- 7.衛教病人經常做運動，運動可調節神經系統、增強心血管功能，進而改善低血壓症狀。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 邱冠蓉、余珮華、吳秉勳(2025)・慢性腎臟病患者的鐵質缺乏症：病因、診斷及治療新進展・內科學誌，36(1)，55-66。
- (二) 陳淑明、賴威翔、方德昭(2023)・腎性貧血與治療・腎臟與透析，35(1)，2-4。
- (三) 曾宇碩、黃建維、李柏蒼(2021)・慢性腎臟病合併癌症病人之貧血與紅血球生成刺激劑・腎臟與透析，33(2)，68-72。
- (四) 楊凱翔、林思雯、吳宗昱、許舒涵、陳珮君(2024)・慢性腎臟病貧血新藥：缺氧誘導因子脯氨酰羧化酶抑制劑・北市醫學雜誌，21(4)，326-337。
- (五) 謝秀幸(2021)・一般內科的不尋常是血液透析室的日常:腎性貧血與高血磷症・臨床醫學月刊，88(1)，458-462。

七、附件

(略)

主題名稱	腎性貧血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E06	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	醫護部改護理部及修正錯別字	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動	
104.08.31	3.1	更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	第三項說明內容部份修辭及新增參考文獻於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	第六項參考資料增刪及修訂	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動	
107.09.12	3.4	1. 第二項新增（含中興分院） 2. 第六項第二、五目參考資料修訂	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	1. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施 2. 更新第六項參考資料	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動	
110.09.07	3.6	1. 參考文獻於內文引用呈現方式，依 APA 格式第七版規範修訂 2. 更新第六項參考資料	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過；110 年 08 月 11 日護理長會議通過;110 年 09 月 07 日督導會議通過公布

主題名稱	腎性貧血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E06	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/8

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	3.7	1. 第三項第五目護理問題內容說明修訂 2. 第三項第六目護理措施內容說明修訂 3. 更新第六項參考資料 4. 內文參考文獻引用刪除	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布
112.09.05	3.8	更新第六項參考資料	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布
113.09.03	3.9	1. 第三項第一目定義內容說明修訂 2. 第三項第四目常見治療內容修訂 3. 更新第六項參考資料	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布
114.10.08	4.0	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	腎性貧血	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-E06	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註